

Результаты химиотерапии фторпиримидинами в комбинации с цисплатином распространенного первичного рака печени

Омарова И.М., Кожамбердин К.Е.

Карагандинский областной онкологический диспансер

Первичный рак печени представляет серьезную проблему для здравоохранения. По данным международного агентства по изучению рака в мире ежегодно погибает более полумиллиона человек [1, 2].

Интерес к проблеме лечения первичного рака печени обусловлен всё ещё неудовлетворительными результатами лечения пациентов. Общий прогноз при первичном раке печени неблагоприятный, даже при использовании современных методов лечения пятилетняя выживаемость редко превышает 5% [2, 3, 4].

В ряде случаев системная химиотерапия остается единственным методом лечения больных первичным раком печени. Однако результаты системной химиотерапии остаются недостаточно удовлетворительными, так как стандартные подходы к проведению системной химиотерапии первичного рака печени ещё не разработаны, проводятся исследования различных схем полихимиотерапии (ПХТ). По данным многочисленных исследований противоопухолевую активность проявляют режимы с включением доксорубина, цисплатина, гемцитабина. Частота эффективности различных схем химиотерапии колеблется от 12 до 36% [5,6,7].

В связи с этим, актуальной задачей остается разработка новых эффективных режимов системной химиотерапии первичного рака печени.

Цель исследования

– изучение сравнительной эффективности цисплатина в комбинации с 5-фторурацилом или капецитабином в первой линии химиотерапии первичного рака печени

Материал и методы исследования: В данное нерандомизированное исследование включено 44 пациента (32 мужчин и 12 женщин) в возрасте от 34 до 76 лет с морфологически подтвержденным диагнозом распространенного первичного рака печени III – IV стадии (таблица 1).

В подгруппе А полихимиотерапия проведена по схеме: 5-ФУ 500мг/м² внутривенно в 1, 3, 5, 8 дни и цисплатин 100мг/м² внутривенно капельно в 1 день каждого 28 дневного цикла.

В подгруппе В полихимиотерапия проведена по схеме: капецитабин 1000мг/м² 2 раза в день внутрь с 1 по 14 дни и цисплатин 100мг/м² внутривенно капельно в 1 день каждого 28 дневного цикла.

Результаты и обсуждение

Исследуя фармакодинамику комбинированных режимов ПХТ фторпиримидинами (5-ФУ, капецитабин) с цисплатином, мы в качестве ключевого момента, выбрали химиотерапевтическую активность, частоту и профиль токсичности этих режимов и отдаленные результаты лечения

Оценка эффективности методов лечения первичного рака печени, осуществлялась на основе сравнительного анализа непосредственной эффективности и отдаленных результатов лечения

В таблице 2 представлены результаты непосредственной эффективности проведенных режимов ПХТ.

Таблица 1. Характеристика больных первичным раком печени

Характеристика	Подгруппа А 5-фторурацил+цисплатин	Подгруппа В Капецитабин+цисплатин
Количество больных	28	16
Пол		
Мужской	21	11
Женский	7	5
Средний возраст	58	57,6
Возрастная медиана	39 -73	41-71
III стадия	18	9
IV стадия	10	7

Таблица 2. Эффективность ПХТ фторпиримидинами в комбинации с цисплатином у больных первичным раком печени

Группы лечения	Эффективность лечения		
	Частичный регресс	Стабилизация заболевания	Прогрессирование заболевания
5-ФУ+ цисплатин (n=28)	4 (14,3 ± 6,7)%	9 (32,1 ± 8,9)%	15 (53,6 ± 9,6)%
Капецитабин+ Цисплатин* (n=16)	3 (18,7 ± 10,1)%	6 (37,5 ± 15,5)%	7 (43,8 ± 12,8)%

* достоверность P ≥ 0,05 по сравнению с группой 5-ФУ + цисплатин, различия не достоверны

Таблица 4. Выживаемость больных первичным раком печени, в зависимости от режима проводимой ПХТ

Выживаемость с учетом дожития (X ± m %)	5-ФУ+ цисплатин (n=28)	Капецитабин + цисплатин (n=16)
3 месяца	(98,2 ± 2,5)%	(93,7 ± 6,1)%
6 месяцев	(80,8 ± 7,3)%	(81,2 ± 9,8)%
9 месяцев	(56,1 ± 9,2)%	(66,5 ± 12,4)%
12 месяцев	(35,1 ± 8,9)%	(60,9 ± 13,6)%*
Медиана выживаемости (месяцев)	10,7 ± 1,5	14,4 ± 1,*

Примечание – * достоверность по сравнению с подгруппой 5-ФУ+цисплатин (P ≤ 0,0001)

Сравнение результатов непосредственной эффективности химиотерапии между подгруппами не выявило достоверных различий.

Оценка безопасности лечения проводилась после завершения каждого курса химиотерапии. В условиях нашего наблюдения переносимость химиотерапии была удовлетворительной, непредвиденных побочных эффектов не зарегистрировано (таблица 3).

В подгруппе А общая частота гематологических осложнений составила 35,7%. Умеренная нейтропения наблюдалась в 25,0% случаев, тяжелая нейтропения III–IV степени зарегистрирована у 7,1% пациентов. Тромбоцитопения I – II степени наблюдалась у 14,3%, тромбоцитопения III – IV степени у – 3,6%, анемия I – II степени – у 28,6%, анемия III – IV степени – у 7,1 % пациентов.

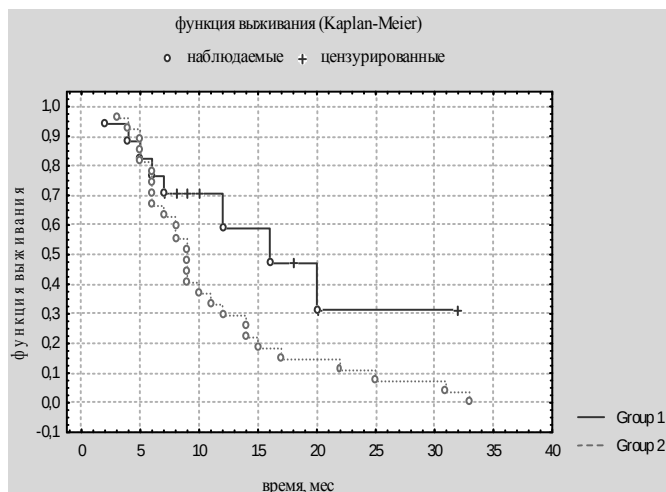


Рисунок. Выживаемость по Kaplan –Meier больных первичным раком печени, в зависимости от режима проводимой ПХТ

В подгруппе В общая частота гематологических осложнений составила 31,2%. Умеренная нейтропения наблюдалась в 18,7% случаев, тяжелая нейтропения III – IV степени тяжести не зарегистрирована. Тромбоцитопения I – II степени наблюдалась у 12,5%, тромбоцитопения III – IV степени у – 6,2%, анемия I – II степени – у 31,2%, анемия III – IV степени – у 6,2% пациентов.

Умеренные тошнота и рвота наблюдались у 21,4% пациентов подгруппы А и у 25,0% пациентов подгруппы В, мукозиты и диарея соответственно у 10,7% и 12,5% пациентов. Умеренная периферическая полинейропатия отмечалась у 7,1% пациентов подгруппы А и у 12,5% больных подгруппы В.

Токсический профиль в обеих подгруппах был практически одинаковым, однако следует отметить, что у 37,5% больных подгруппы В отмечался ладонно-подошвенный синдром.

Пригодными для оценки выживаемости в подгруппе А явились все 28 пациентов, которым проведено 86 курсов ПХТ 5-ФУ в комбинации с цисплатином. При использовании этой комбинации удалось достичь 3-месячной выживаемости у 98,2%, 6-месячной выживаемости – у 80,7%, 9-месячной выживаемости – у 56,1%, годовичной выживаемости – у 35,1% пациентов. Медиана наблюдаемой выживаемости составила 10,7±1,5 месяцев (таблица 4).

В подгруппе В проведение 16 пациентам 46 курсов ПХТ капецитабином в комбинации с цисплатином позволило достичь 3-месячной выживаемости у 93,7%, 6-месячной выживаемости – у 81,2%, 9-месячной выживаемости – у 66,5%, годовичной выживаемости – у 60,9% пациентов. Медиана выживаемости достигла 14,4±1,6 месяцев.

Результаты исследования показали, что комбинация капецитабин+ цисплатин достоверно (Cox's F-Test: F=3,7; P=0,00014) увеличивает годовичную выживаемость с 35,1% до 60,9% и медиану выживаемости с 10,7 до 14,4 месяцев по сравнению с комбинацией 5-ФУ+цисплатин (рисунок)

Функция выживания выражена в долях.

Group 1 – капецитабин + цисплатин; Group 2 – 5-ФУ + цисплатин.

Заключение

Таким образом, проведенное клиническое исследование комбинированных режимов ПХТ фторпиримидинами с цисплатином в качестве I линии химиотерапии распространенного рака печени показало удовлетворительные непосредственные и отдаленные результаты лечения. Кроме того, изученные комбинации продемонстрировали уровень токсичности приемлемый для клиники.

Результаты, полученные в исследовании сопоставимы с обобщенными литературными данными по эффективности и безопасности системной ПХТ у пациентов первичным раком печени [8,9, 10, 11]

Литература

1. Пасечников В. Д. Чуков С. З. Некоторые вопросы эпидемиологии, диагностики и лечения гепатоцеллюлярной карциномы // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2002. – Т. 12, № 2. – С. 30 – 37.
2. Thomas M. B. Systemic therapy for hepatocellular carcinoma // Cancer. – 2008. – Vol. 14, № 3. – P.123 – 127.
3. Treatment of hepatocellular carcinoma: A systematic review of randomized controlled trials / Simonetti R. G., Leberati A., Angiolini C. et al. // Ann. Oncol. – 1997, Vol. 8. – P. 117– 136.
4. Systemic therapy for hepatocellular carcinoma: cytotoxic chemotherapy, targeted therapy and immunotherapy / Thomas M. B., O'Beirne J. P., Furuse J. et al. // Ann. Surg. Oncol. – 2008. – Vol. 15, № 4. – P. 1008 – 1014.
5. Johnson P. J. Are there indications for chemotherapy in hepatocellular carcinoma? // Surg. Oncol. Clin. N. Am. Jan. – 2003. – Vol. 12, № 1. – P. 127 – 134.
6. Poh S.B., Bai L.Y., Chen P.M. Pegylated liposomal doxorubicin-based combination chemotherapy as salvage treatment in patients with advanced hepatocellular carcinoma // Am. J. Clin. Oncol. – 2005. – Vol. 28, № 6. – P. 540 – 546.
7. A randomized phase III study of doxorubicin versus cisplatin/interferon alpha-2b/doxorubicin/fluorouracil (PIAF) combination chemotherapy for unresectable hepatocellular carcinoma / Yeo W., Mok T.S., Zee B. et al. // J. Natl. Cancer Inst. – 2005. – Vol. 97, № 20. – P.1532 – 1538.
8. Phase II study with a combination of epirubicin, cisplatin, UFT, and leucovorin in advanced hepatocellular carcinoma / Kim S. J., Seo H. Y., Choi J. G. et al. // Cancer Chemother. Pharmacol. – 2006. – Vol. 57, № 4. – P. 436 – 442.
9. Phase II study of doxorubicin and cisplatin in patients with metastatic hepatocellular carcinoma/ Lee J., Park J. O., Kim W. S. et al. // Cancer Chemother. Pharmacol. – 2004. – Vol. 54, № 5. – P. 385 – 390.
10. Treatment of advanced hepatocellular carcinoma with gemcitabine plus oxaliplatin / Li S., Niu Z., Tian H. et al. // Hepatogastroenterology. – 2007. – Vol. 54, № 73. – P. 218 –223.
11. Multicentre phase II trial of capecitabine plus oxaliplatin (XELOX) in patients with advanced hepatocellular carcinoma: FFCD 03-03 trial / Boige V., Raoul J. L., Pignon J. P. et al. // Br. J. Cancer. – 2007. – Vol. 97, № 7. – P. 862 –867.